

Divisão:

Tempo	Quem	Bloco
00:00–02:20	Pessoa 1	Slides 1–4
02:20–04:10	Pessoa 2	Slides 5–6
04:10–06:00	Pessoa 3	Slides 7–9
06:00–09:45	Pessoa 4	Demo Administrador
09:45–13:00	Pessoa 5	Demo Enfermeiro
13:00–16:15	Pessoa 6	Demo Médico
16:15–20:00	Pessoa 7	Demo Paciente + Encerramento

(~6 min de slides + ~14 min de demo = 20:00)

PESSOA 1 — 00:00 a 02:20 — Slides 1 a 4 (*ritmo ágil, sem pausas longas*)

[Capa] "Boa noite, professores e professoras. Somos a equipe do TCC em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e apresentamos o MedIT — uma plataforma web de apoio à triagem e à organização do fluxo hospitalar." *[Equipe — "Eu sou ___, responsável por ___"]* "Somos sete integrantes, e cada um conduz uma parte em sequência; conforme assumimos."

[Problema] "O problema é real nas unidades públicas: superlotação e filas imprevisíveis, triagem e cadastro manuais com retrabalho e risco de erro, histórico fragmentado e falta de transparência sobre espera e medicamentos."

[Objetivo/Impacto] "Nosso objetivo foi organizar a jornada de ponta a ponta — cadastro digital, pré-atendimento remoto, fila automática e histórico centralizado — com controle por perfil e sugestões por regras, como apoio e nunca substituição do profissional. Passo para a arquitetura."

PESSOA 2 — 02:20 a 04:10 — Slides 5 e 6

[apresentação pessoal]

[Arquitetura] "O MedIT é um monorepo. Front-end em React com Vite e Sass; back-end em Node.js e Express com TypeScript; persistência em MongoDB com Mongoose; comunicação via API REST. Autenticação JWT com access e refresh token, e senhas com hash bcrypt."

[Módulos/Perfis] "São quatro perfis, com permissões escopadas por unidade: administrador, enfermeiro, médico e paciente. É nessa ordem que percorremos o

sistema ao vivo, seguindo o fluxo operacional real. Antes, o fluxo de estados e as regras."

PESSOA 3 — 04:10 a 06:00 — Slides 7 a 9

[apresentação pessoal]

[Fluxo] "O atendimento é uma máquina de estados, com seis estados — Em Rota, Aguardando Triagem, Em Triagem, Aguardando Médico, Em Atendimento e Atendimento Concluído. Cada transição fica no changesHistory, para auditoria e rastreabilidade."

[Segurança] "A segurança tem três camadas: perfil, unidade pelo unitId, e titularidade do episódio — um médico não abre o atendimento de outro. Mais o claim atômico na fila: um profissional por caso."

[IA] "As sugestões são IA simbólica: pesos de sintomas sobre base curada, em percentual de compatibilidade, explicável. Não é generativa, não é diagnóstico automático, não integra o SUS — a decisão é do médico. Vamos ao sistema, pelo administrador."

PESSOA 4 — 06:00 a 09:45 — Demo Administrador (agora com tempo para o CRUD completo)

[apresentação pessoal]

"Entro como administrador — gestão de uma unidade específica, não da rede. No dashboard, indicadores da própria unidade: entradas, em atendimento, atendidos e ocupação, com filtro por período; aqui o gráfico e a fila administrativa. Em Médicos, atenção: é a lista da unidade do administrador logado, não de todos — cada usuário tem um unitId no token e o back filtra. Cadastro um médico ao vivo, edito um campo e abro o detalhe, pra mostrar que não dependemos só de dados pré-carregados. A mesma lógica em Enfermeiros: cadastro e edito. Em Pacientes, o administrador consulta e edita quem já está vinculado — o cadastro inicial é feito pelo próprio paciente, na tela pública. Em Unidades parceiras vejo a rede; em Medicamentos, o estoque da unidade com status de disponibilidade — quando falta um item, o sistema orienta a busca nas parceiras, sem quebrar o isolamento entre unidades. Passo para a enfermagem."

PESSOA 5 — 09:45 a 13:00 — Demo Enfermeiro

[apresentação pessoal]

"Assumo a enfermagem. Na fila de triagem, os pacientes da unidade ainda sem enfermeiro. Clico em Iniciar triagem — o claim atômico: o caso é atribuído a mim e

abre o detalhe. Recebo o que o paciente informou no pré-atendimento — queixa e sintomas —, reduzindo repetição. Registro os sinais vitais — temperatura, pressão, frequência, saturação — e a classificação de risco. Ao concluir, o status vai para Aguardando atendimento médico e entra na fila do médico da unidade. No histórico, acompanho as triagens que realizei, com rastreabilidade. Passo para o médico."

PESSOA 6 — 13:00 a 16:15 — Demo Médico

[apresentação pessoal]

"No perfil médico, continuamos o mesmo episódio que saiu da triagem. Na fila, Iniciar atendimento — mesmo claim, um médico por caso. O médico recebe a continuidade clínica: vitais, risco e sintomas, sem recomençar. Na lateral, as Condições sugeridas com o percentual de compatibilidade; abrindo o detalhe, vejo os sintomas de referência e o que a base sugere, com transparência. Para finalizar, seleciono o diagnóstico do catálogo, registro prescrição e exames e defino o destino do paciente. O episódio fecha, com resumo e rastreabilidade para histórico e indicadores. Passo para a jornada do paciente."

PESSOA 7 — 16:15 a 20:00 — Demo Paciente + Encerramento

[apresentação pessoal]

"Fechamos com o paciente, onde a jornada começa — fora da unidade. Qualquer pessoa cria conta na tela pública, vinculada a uma unidade. No pré-cadastro, informa queixa, início dos sintomas, nível de dor e seleciona os sintomas — tudo estruturado para a triagem. O status inicial é 'Em Rota': ainda não está na fila. Ao Confirmar chegada, o caso entra na fila operacional — conectando tudo que vimos no administrador, na enfermagem e no médico, sem repetir dados."

[Slide 10 — Encerramento] "Concluimos o MedIT: nos slides, contexto e arquitetura; na prática, gestão por unidade, cadastro de equipe, triagem estruturada, atendimento com apoio por regras e a jornada do paciente de ponta a ponta. O sistema organiza o fluxo e apoia a decisão, sem substituir o profissional de saúde. Agradecemos a atenção da banca e ficamos à disposição para perguntas."

Cada pessoa dá uma **frase rápida de apresentação** quando assume o microfone, antes de entrar na sua parte.

"Eu sou o [nome], fui responsável pelo back-end e pelas regras de acesso — e vou mostrar o sistema pelo perfil de administrador."